

Bio/necropulpectomía de primer premolar superior

v0.1 · borrador · borrador sin revisión de especialista · 2026-10-06

Fuentes, el porqué de cada paso y la versión vigente
criterium-e5d90.web.app/#proto/pulpectomia-premolar



PIEZA (1.4 / 2.4)	DX PULPAR	LAD · 2/3 LAD	LRD V / P
LT V / P	LIMA INICIAL V / P	LIMA MAESTRA V / P	

PASO A PASO

01 ☐ Diagnóstico pulpar y periapical

Haz las pruebas de sensibilidad al frío, primero en dos o tres dientes control y después en el diente en estudio. Completa con percusión, palpación y sondaje.

02 ☐ Radiografía y cálculos previos

En la radiografía mide la longitud aparente del diente (LAD), marca sus dos tercios y mide la distancia desde tu referencia coronal hasta el techo de la cámara.

03 ☐ Prepara el diente antes de entrar

Elimina la caries y las restauraciones defectuosas, y reconstruye las paredes que falten con resina compuesta.

04 ☐ Anestesia y cavidad de acceso

Anestesia. Entra por el tercio del surco hacia la cúspide vestibular con fresa de diamante perpendicular a la superficie y, al llegar a dentina, sigue con carburo de baja velocidad paralelo al eje del diente.

05 ☐ Aislamiento absoluto paso crítico

Instala el dique de goma y amarra el clamp al arco con hilo dental. Desinfecta el campo. Nunca dejes algodón bajo el dique.

06 ☐ Prepara los tercios cervical y medio

Explora con una lima #10 hasta los 2/3 de la LAD e irriga. Después ensancha los tercios cervical y medio con fresas Gates Glidden, sin pasar de los 2/3 de la LAD. → *secuencia 1-2-1 si el conducto es fino o medio, 3-2-1 si es amplio*

07 ☐ Mide la longitud con el localizador en disputa

Con el conducto húmedo y la cámara seca, lleva una lima K10 o K15 con el localizador hasta «0.0», ajusta el tope y mide. Repite para confirmar. Resta 1 mm y toma la radiografía de conductometría.

08 ☐ Irriga durante toda la preparación

Irriga con hipoclorito de sodio durante toda la preparación, con la aguja precurvada y con tope a 2/3 de la LT, sin trabar la aguja ni empujar fuerte. Aspira de forma continua. → *concentración según el protocolo de tu clínica: la evidencia no muestra diferencia entre 1 % y 5 %*

09 ☐ Instrumenta el tercio apical

Define la lima inicial (la primera que llega a la LT con leve retención). Amplía 4 o 5 limas sobre ella, con entrada pasiva y salida activa, hasta una lima maestra de al menos #30. Pasa una lima fina de permeabilidad entre cada lima.

10 ☐ Escalona con recapitulación (step-back)

Lleva la lima siguiente a LT – 1 mm, después a – 2 mm y a – 3 mm, y sigue hasta empalmar con el tercio medio. Entre cada lima: irriga, recapitula con la lima maestra a LT, irriga, pasa la lima de permeabilidad e irriga. → *completo en el conducto vestibular y después, desde el principio, en el palatino*

11 ☐ Irrigación final

Irriga en este orden: hipoclorito, suero fisiológico, EDTA al 17 % durante 1 minuto y suero fisiológico. Si usas clorhexidina, va al final, después del suero.

NO TE LO SALTES

05 Terminaste cuando el dique sella alrededor del diente, el clamp está amarrado y no hay algodón entre el dique y la encía.

14 Terminaste cuando el sellado coronario está completo, la oclusión ajustada y la cita de rehabilitación quedó agendada en ese momento.

INSTRUMENTAL

DIAGNÓSTICO

- ☐ Espejo, sonda curva, sonda recta y sonda periodontal
- ☐ Spray de frío y torundas
- ☐ Papel de articular
- ☐ Regla de endodoncia
- ☐ Radiografías periapicales

ACCESO Y AISLAMIENTO

- ☐ Fresa redonda de diamante de alta velocidad
- ☐ Fresa redonda de carburo de baja velocidad
- ☐ Fresa de punta inactiva (tipo Endo Z)
- ☐ Dique, arco, perforador, portaclamp y clamps
- ☐ Hilo dental para amarrar el clamp
- ☐ Resina compuesta y adhesivo, si hay que reconstruir

PREPARACIÓN DEL CONDUCTO

- ☐ Fresas Gates Glidden
- ☐ Limas K de primera y segunda serie
- ☐ Topes de goma
- ☐ Localizador apical con su asa labial y clip
- ☐ Jeringas con aguja de irrigación y tope
- ☐ Hipoclorito de sodio
- ☐ Suero fisiológico
- ☐ EDTA al 17 %
- ☐ Clorhexidina al 2 %, si corresponde
- ☐ Cánulas de aspiración y conos de papel estériles

ENTRE SESIONES

- ☐ Hidróxido de calcio con vehículo o en jeringa
- ☐ Torundas de algodón estériles
- ☐ Material de obturación provisional
- ☐ Ionómero de vidrio

OBTURACIÓN Y SELLADO

- ☐ Conos de gutapercha maestro y accesorios
- ☐ Cemento sellador
- ☐ Loseta y espátula
- ☐ Espaciadores y atacadores
- ☐ Fuente de calor para cortar la gutapercha
- ☐ Alcohol y torundas

EN DISPUTA

07 El protocolo docente usa LT = LRD – 1 mm y un apunte de aula usa LRD – 0,5 mm. Pendiente de resolución por el panel.

12 ☐ **Medica si no terminas hoy**

Si el tratamiento sigue en otra sesión, lleva hidróxido de calcio hasta LT – 1 o – 2 mm, girando la lima en sentido antihorario o con jeringa. Sella con torunda estéril, 2 mm de obturación provisional e ionómero encima. → *solo si el tratamiento no se completa en una sesión*

13 ☐ **Conometría y obturación**

Elige un cono maestro que llegue a la LT con retención en los últimos 2 a 3 mm y confírmalo con radiografía. Cementa con sellador, compacta lateralmente con al menos tres conos accesorios y toma la radiografía de control.

14 ☐ **Sella la corona y rehabilita pronto** paso que suele faltar

Corta la gutapercha 1 mm bajo el cuello, limpia la cámara con alcohol y haz el doble sellado coronario. Ajusta la oclusión, da las indicaciones y deja agendada la rehabilitación definitiva.
